



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 838.1/I-KEP/DIR/IX/2025**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang : a. guna mewujudkan visi, misi, nilai dasar, dan moto Rumah Sakit Prima Husada, diperlukan seorang pejabat yang berwenang, bertanggungjawab, dan bertugas merencanakan, mengatur, serta mengawasi segala kegiatan kerja, baik dalam hal manajerial kedinasan maupun fungsi profesinya disetiap bagian;
- b. bahwa Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 017/DPM/I-KEP/DIR/IX/2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada sudah tidak sesuai dengan Rumah Sakit Tipe C;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
6. Akta Pendirian Perseroan Terbatas “ PT. Disa Prima Medika “ yang dibuat oleh surat notaris Endang Merduwati, SH Nomor 26 tanggal 28 November 2009;
7. Keputusan Komisaris Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 325/DPM/I-KEP/KOM/IV/2022 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perseroan Terbatas Disa Prima Medika
8. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA.**
- Pertama : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Struktur Organisasi di Rumah Sakit Prima Husada.



Ketiga : Tata Laksana Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada adalah :

1. Mendukung perencanaan klinik dan pengembangan kebijakan.
2. Mendukung pengawasan atas berbagai isu etika profesi.
3. Mendukung pengawasan atas mutu pelayanan klinik.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

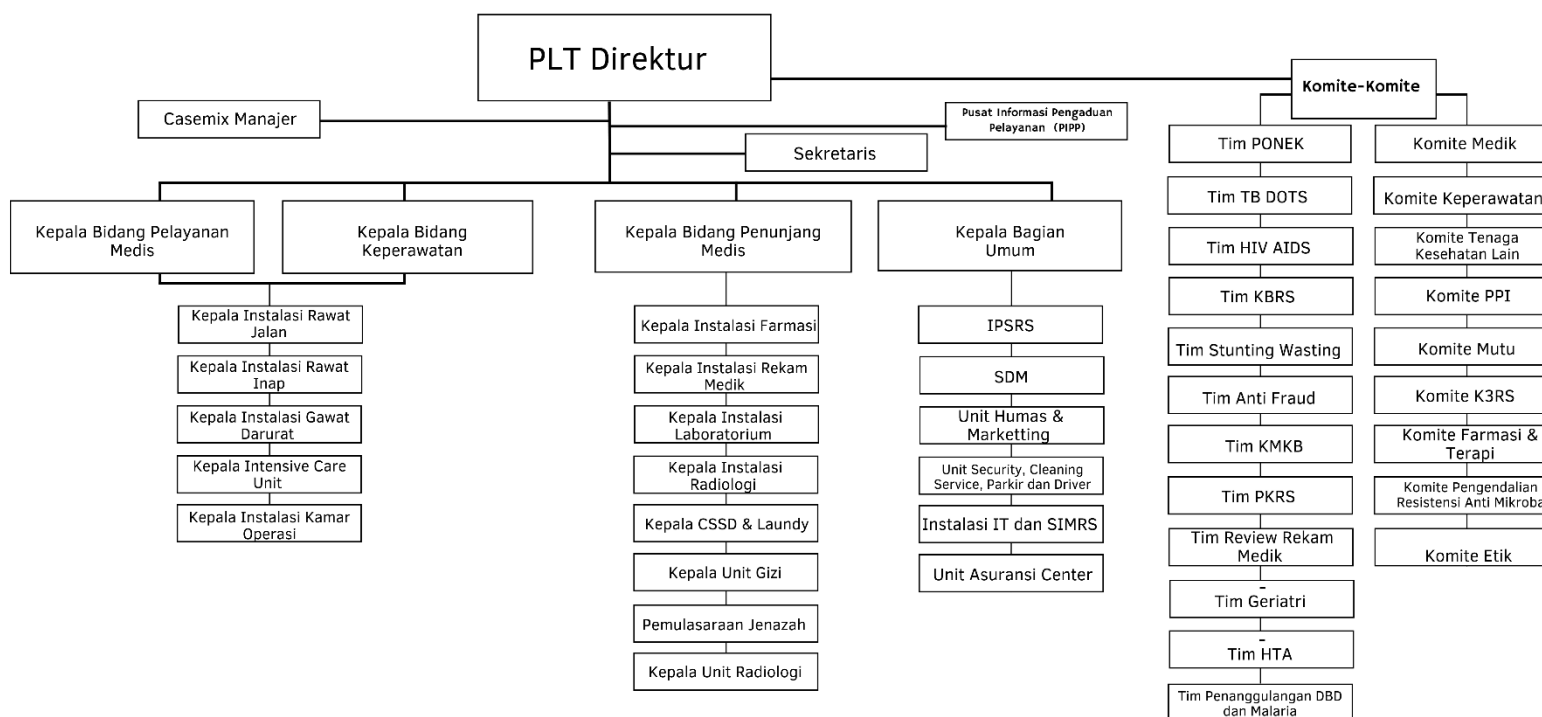
Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 10 September 2025
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR : 838.1/I-KEP/DIR/IX/2025
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

STRUKTUR ORGANISASI RS PRIMA HUSADA MALANG





BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Rumah Sakit Prima Husada bertujuan :
 - a. Tercapainya pelayanan yang bermutu tinggi yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.
 - b. Terus meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.
 - c. Tercapainya peningkatan produktivitas pelayanan.
 - d. Terbentuknya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, memiliki integritas, komitmen yang kuat terhadap organisasi melalui upaya pendidikan dan pelatihan, serta upaya peningkatan kesejahteraan yang adil dan manusiawi.
2. PT Disa Prima Medika adalah sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Malang, sebagai pemilik Rumah Sakit Prima Husada.
3. Rumah Sakit Prima Husada adalah Rumah Sakit Umum yang terletak di Jl. Banjararum Selatan No. 3 – 7 RT 003 RW 012 Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

1. Rumah Sakit Prima Husada merupakan rumah sakit umum yang memberikan pelayanan Umum dan Spesialis.
2. Rumah Sakit Prima Husada dipimpin oleh seorang Direktur Rumah Sakit yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur PT. Disa Prima Medika.

Pasal 3

Rumah Sakit Prima Husada mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan paripurna yang dilandasi kompetensi dan etika profesi, serta berorientasi pada keselamatan pasien, kepuasan pelanggan, dan pelayanan bermutu tinggi.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, Rumah Sakit Prima Husada mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pelayanan kesehatan umum dan spesialis.
- b. melaksanakan upaya preventif, promotif, dan kuratif.
- c. melaksanakan pelayanan rujukan.
- d. melaksanakan upaya peningkatan kompetensi melalui program pelatihan dan pengembangan;
- e. melaksanakan upaya pengembangan pelayanan melalui pembentukan jejaring dengan berbagai pihak.
- f. melaksanakan program mutu untuk secara terus menerus meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- g. melaksanakan administrasi umum dan manajemen keuangan.



BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi Rumah Sakit Prima Husada terdiri dari :

1. Direktur RS Prima Husada
2. Satuan Pemeriksaan Internal
3. Kepala Bidang Pelayanan Medis
4. Kepala Bidang Keperawatan
5. Kepala Bidang Penunjang Medis
6. Kepala Bidang Umum dan Keuangan
7. Komite Medik
8. Komite Keperawatan
9. Komite Tenaga Kesehatan Lain
10. Komite PPI
11. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien
12. Komite Etik
13. Komite Farmasi dan Terapi
14. Komite K3RS (Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit)
15. Komite Pengendalian Resistensi Anti Mikroba
16. Manajer Pelayanan Pasien (MPP)
17. Tim Review Rekam Medis
18. Tim TB DOTS
19. Tim PONEK
20. Tim HIV
21. Tim Geriatri
22. Tim Stunting dan Wasting
23. Tim Keluarga Berencana Rumah Sakit
24. Tim PKRS
25. Tim KMKB
26. Tim Anti Fraud
27. Tim HTA
28. Tim Penanggulangan DBD dan Malaria

Pasal 6

Direktur RS Prima Husada bertanggung jawab kepada Direktur PT Disa Prima Medika dan mempunyai tugas memimpin, merumuskan kebijaksanaan, pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan, mengawasi pelaksanaan tugas rumah sakit, dan menerima pelaporan dari Satuan Pemeriksaan Internal sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 7

Satuan Pemeriksaan Internal membantu Direktur Rumah Sakit dalam melaksanakan analisis dan evaluasi efektifitas sistem dan prosedur pada seluruh Instalasi Rumah Sakit. Satuan Pemeriksaan Internal mempunyai fungsi:

- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
- b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;



- c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur Rumah Sakit;
- d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit;
- e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit;

Pasal 8

Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Kepala Bidang Keperawatan bertanggung jawab kepada Direktur mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan supervisi operasional, serta menyiapkan seluruh kebutuhan Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, *Intensive Care Unit*, Instalasi Kamar Operasi, Instalasi Farmasi, Instalasi Rekam Medis, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Instalasi Central Sterile Supply Department dan Laundry. Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Keperawatan dan Kepala Bidang Penunjang mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyusunan kebutuhan sumber daya manusia, peralatan medis dan non medis, serta perbekalan farmasi yang dibutuhkan;
- b. Melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan;
- c. Melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan sumber daya manusia dalam lingkup kerjanya;
- d. Menyusun perencanaan tahunan dan rencana pengembangan pelayanan.
- e. Membuat perencanaan, memelihara/mempertahankan, memantau, mengevaluasi dan memberikan masukan terkait program pengendalian mutu di instalasi yang dipimpinnya

Pasal 9

Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Keperawatan dan Kepala Bidang Penunjang bertanggung jawab kepada Direktur mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan supervisi operasional keperawatan, serta mengkoordinasikan pemenuhan kebutuhan sumber daya keperawatan baik jumlah dan kualifikasi di seluruh instalasi/unit/komite/tim/panitia yang menggunakan tenaga keperawatan. Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Keperawatan dan Kepala Bidang Penunjang mempunyai fungsi:

- a. Melakukan perencanaan, koordinasi dan supervisi dalam operasional Instalasi di dalam jajarannya;
- b. Melakukan penyusunan kebutuhan sumber daya manusia, peralatan medis dan non medis, serta perbekalan farmasi yang dibutuhkan;
- c. Melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan;
- d. Melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan sumber daya manusia dalam lingkup kerjanya;
- e. Menyusun perencanaan tahunan dan rencana pengembangan pelayanan.
- f. Membuat perencanaan, memelihara/mempertahankan, memantau, mengevaluasi dan memberikan masukan terkait program pengendalian mutu di instalasi yang dipimpinnya

Pasal 10

Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Kepala Bidang Keperawatan membawahi :

- a. Instalasi Rawat Jalan
- b. Instalasi Rawat Inap
- c. Instalasi Gawat Darurat
- d. Intensive Care Unit (ICU)
- e. Instalasi Kamar Operasi (IKO)

Pasal 11



Kepala Bidang Penunjang Medis membawahi :

- a. Instalasi Farmasi
- b. Instalasi Rekam Medis
- c. Instalasi Laboratorium
- d. Instalasi Radiologi
- e. Instalasi CSSD dan Laundry
- f. Instalasi Gizi
- g. Pemulasaran Jenazah

Pasal 12

Kepala Bidang Umum dan Keuangan bertanggung jawab kepada Direktur mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan dan melaksanakan supervisi operasional, serta menyiapkan seluruh kebutuhan urusan keuangan dan laporan akuntansi rumah sakit untuk menunjang pelayanan RS Prima Husada.
- b. Menyiapkan kebutuhan sumber daya manusia, fasilitas dan bahan – bahan yang dibutuhkan serta melakukan penyiapan pemantauan dan pelaksanaan administrasi keuangan rumah sakit.
- c. Menyiapkan seluruh kegiatan kebutuhan manajemen SDM dan Diklat, Ketata Usahaan dan Hubungan Masyarakat, Keuangan dan Akuntansi, pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, Umum dan Kerumah Tanggaan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit ,Asuransi Centre untuk menunjang pelayanan RS Prima Husada.

Kepala Bidang Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan koordinasi dalam perencanaan dan operasional keuangan dan akuntansi rumah sakit;
- b. Melakukan penyusunan kebutuhan sumber daya manusia, peralatan dan bahan – bahan yang dibutuhkan;
- c. Melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan keuangan dan akuntansi rumah sakit;
- d. Melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan sumber daya manusia dalam lingkup kerjanya;
- e. Menyusun perencanaan tahunan dan rencana pengembangan keuangan dan akuntansi rumah sakit.
- f. Membuat perencanaan, memelihara/mempertahankan, memantau, mengevaluasi dan memberikan masukan terkait program pengendalian mutu di keuangan dan akuntansi.

Pasal 13

Kepala Bidang Umum dan Keuangan membawahi :

- a. Unit Keuangan dan Akuntansi
- b. Unit SDM dan Diklat
- c. Unit Humas dan Marketing
- d. Unit PIPP
- e. Unit Umum dan Rumah Tangga
- f. Instalasi IT dan SIMRS
- g. Instalasi Asuransi Center
- h. IPSRS
- i. Unit Umum Cleaning Service



Pasal 14

1. Sekretaris mempunyai tugas administrasi dan ketata arsip dan menyiapkan kebutuhan rapat, fasilitas dan bahan yang dibutuhkan serta melakukan pemantauan dan pelaksanaan sistem rapat rumah sakit.
2. Hubungan Masyarakat mempunyai tugas supervisor pelaksanaan riset dan analisis pasar, perumusan strategi pemasaran, sales, promosi dan riset pesaing
3. Bagian SDM mempunyai tugas menyiapkan kebutuhan sumber daya manusia, fasilitas dan bahan – bahan yang dibutuhkan serta melakukan penyiapan pemantauan dan pelaksanaan manajemen SDM dan program pendidikan dan pelatihan SDM Rumah Sakit.
4. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi mempunyai tugas menyiapkan kebutuhan sumber daya manusia, fasilitas dan bahan-bahan yang dibutuhkan serta melakukan penyiapan pemantauan dan pelaksanaan pelaporan akuntansi rumah sakit
5. Bagian sistem informasi manajemen rumah sakit mempunyai tugas menyiapkan kebutuhan sumber daya manusia, fasilitas dan bahan – bahan yang dibutuhkan serta melakukan penyiapan pemantauan dan pelaksanaan sistem informasi manajemen rumah sakit.
6. Bagian pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit mempunyai tugas menyiapkan kebutuhan sumber daya manusia, fasilitas dan bahan – bahan yang dibutuhkan serta melakukan penyiapan pemantauan dan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit.
7. Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan kebutuhan sumber daya manusia, fasilitas dan bahan – bahan yang dibutuhkan serta melakukan penyiapan pemantauan dan pelaksanaan pengamanan, transportasi dan kebersihan rumah sakit.
8. Bagian Asuransi Centre mempunyai tugas membantu Direktur Rumah Sakit dalam mengendalikan biaya peserta jaminan kesehatan nasional di rumah sakit

BAB IV
INSTALASI
Pasal 15

1. Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala.
2. Tugas Kepala Instalasi adalah menyiapkan fasilitas agar pelayanan dapat terlaksana dengan baik sesuai standar yang ditetapkan.
3. Kepala Instalasi diangkat oleh Direktur.
4. Organisasi Instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V
KOMITE MEDIK
Pasal 16

1. Komite Medik adalah wadah Kelompok Staf Medik Rumah Sakit Prima Husada.
2. Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur Rumah Sakit dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan oleh Staf Medik, menyusun standar pelayanan, dan memantau pelaksanaannya melalui evaluasi mutu dan audit medik, serta melaksanakan ketentuan sesuai yang tercantum dalam *Medical Staf Bylaws*.
3. Komite Medik terdiri dari Sub Komite Kredensial, Sub Komite Mutu Profesi, dan Sub Komite Etika dan Disiplin.
4. Komite Medik ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit dan mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun.
5. Organisasi Komite Medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit



BAB VI
KOMITE KEPERAWATAN
Pasal 17

1. Komite Keperawatan dan Kebidanan terdiri dari perawat dan bidan, yang bertugas pada Instalasi dalam jabatan fungsional.
2. Komite Keperawatan dan Kebidanan terdiri dari Sub Komite Kredensial, Sub Komite Mutu Profesi, dan Sub Komite Etika dan Disiplin
3. Komite Keperawatan dan Kebidanan mempunyai tugas membantu Direktur Rumah Sakit dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan, menyusun standar pelayanan, dan memantau pelaksanaannya melalui evaluasi asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan.
4. Komite Keperawatan dan Kebidanan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit dan mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun.
5. Organisasi Komite Keperawatan dan Kebidanan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit

BAB VII
KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN
Pasal 18

1. Komite Tenaga Kesehatan Lain terdiri dari tenaga medis, yang bertugas pada bidang penunjang
2. Komite Tenaga Kesehatan Lain terdiri dari Sekretaris, Sub Komite Kredensial, Sub Komite Mutu, dan Sub Komite Etika dan Disiplin
3. Komite Tenaga Kesehatan Lain ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit dan mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun.

BAB VIII
KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)
Pasal 19

1. Komite PPI mempunyai tugas membantu Direktur Rumah Sakit dalam mengkoordinasikan pengendalian infeksi di Rumah Sakit.
2. Komite PPI ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit dan mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun.
3. Organisasi Komite PPI ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

BAB IX
KOMITE MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN
Pasal 20

1. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien mempunyai tugas membantu Direktur Rumah Sakit dalam mengkoordinasikan pelaksanaan mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit.
2. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit dan mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun.



3. Organisasi Komite Mutu dan Keselamatan Pasien ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

BAB X
KOMITE ETIK
Pasal 21

1. Komite Etik mempunyai tugas membantu Direktur Rumah Sakit dalam menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait etika rumah sakit, penyelesaian masalah etika rumah sakit, dan pelanggaran terhadap etika pelayanan rumah sakit.
2. Komite Etik ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit dan mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun.
3. Organisasi Komite Etik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

BAB XI
KOMITE FARMASI DAN TERAPI
Pasal 22

1. Komite Farmasi dan Terapi mempunyai tugas membantu Direktur Rumah Sakit dalam menentukan kebijakan penggunaan obat dan pengobatan di rumah sakit.
2. Komite Farmasi dan Terapi ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit dan mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun.
3. Organisasi Komite Farmasi dan Terapi ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

BAB XII
PANITIA KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA RUMAH SAKIT (P2K3)
Pasal 23

1. Panitia Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit mempunyai tugas membantu Direktur Rumah Sakit dalam menghimpun dan mengolah data mengenai kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit.
2. Panitia Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit dan mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun.
3. Organisasi Panitia Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

BAB XIII
Manajer Pelayanan Pasien (MPP)
Pasal 24

1. Manajer Pelayanan Pasien (MPP) mempunyai tugas membantu Direktur Rumah Sakit dalam menyusun perencanaan pelayanan pasien di rumah sakit
2. Manajer Pelayanan Pasien (MPP) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit

BAB XIV
TIM TB DOTS
Pasal 25

1. Tim TB DOTS mempunyai tugas membantu Direktur Rumah Sakit dalam menyusun pelaksanaan TB di rumah sakit.



2. Tim TB DOTS ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit dan mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun.
3. Organisasi Tim TB DOTS ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

BAB XV
TIM PONEK
Pasal 26

1. Tim PONEK mempunyai tugas membantu Direktur Rumah Sakit dalam pelaksanaan maternal, neonatal dan perinatal di rumah sakit.
2. Tim PONEK ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit dan mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun.
3. Organisasi Tim PONEK ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

BAB XVI
TIM HIV/AIDS
Pasal 27

1. Tim HIV mempunyai tugas membantu Direktur Rumah Sakit dalam pelaksanaan dan pengawasan mengenai HIV
2. Tim HIV ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

BAB XVII
TIM STUNTING DAN WASTING
Pasal 28

1. Tim Stunting dan Wasting mempunyai tugas membantu Direktur Rumah Sakit dalam Prevalensi Stunting dan Wasting pada bayi dan balita
2. Tim Stunting dan Wasting ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

BAB XVIII
TIM KBRS (Keluarga Berencana Rumah Sakit)
Pasal 29

1. Tim Keluarga Berencana Rumah Sakit (KBRS) mempunyai tugas membantu Direktur Rumah Sakit dalam program Keluarga Berencana Rumah Sakit (KBRS)
2. Tim Keluarga Berencana Rumah Sakit (KBRS) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

BAB XIX
TIM PKRS
Pasal 30

1. Tim PKRS mempunyai tugas membantu Direktur Rumah Sakit dalam melaksanakan penyuluhan kesehatan di rumah sakit.
2. Organisasi Tim PKRS ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.



BAB XX TIM KMKB
TIM KMKB
Pasal 31

1. Tim KMKB mempunyai tugas dalam pelaksanaan kendali mutu asuhan pasien rawat inap dan rawat jalan, serta kendali biaya pengobatan pasien rawat inap dan rawat jalan
2. Organisasi Tim PKRS ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

BAB XXI
TIM Anti Fraud
Pasal 32

1. Tim Anti Fraud mempunyai tugas membantu Direktur Rumah Sakit dalam mengendalikan biaya peserta jaminan kesehatan nasional di rumah sakit.
2. Organisasi Tim Pengendali BPJS ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

BAB XXII
Tim Review Rekam Medis
Pasal 33

1. Tim Review Rekam Medis mempunyai tugas membantu Direktur Rumah Sakit dalam Menyusun prosedur pelaksanaan yang berkaitan dengan tugas Panitia Rekam Medis di rumah sakit.
2. Organisasi Tim Review Rekam Medis ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

BAB XXIII
Tim Geriatri
Pasal 34

1. Tim Geriatri mempunyai tugas membantu Direktur Rumah Sakit dalam melaksanakan pelayanan program geriatri di rumah sakit
2. Organisasi Tim Geriatri ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

BAB XXIV
Tim Penampisan Teknologi Kesehatan
Pasal 35

1. Tim Penampisan Teknologi Kesehatan mempunyai tugas membantu Direktur Rumah Sakit dalam menyusun konsep dan program di bidang Penapisan Teknologi Kesehatan di rumah sakit
2. Organisasi Tim Penampisan Teknologi Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

BAB XXV
Tim Penanggulangan DBD dan Malaria
Pasal 36

1. Tim Penanggulangan DBD dan Malaria mempunyai tugas membantu Direktur Rumah Sakit dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan penanggulangan DBD dan Malaria di rumah sakit
2. Organisasi Tim Penanggulangan DBD dan Malaria ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit
3. Membuat laporan terkait kegiatan pelayanan penanggulangan DBD dan Malaria kepada Direktur dan Instalasi terkait



BAB XXVI
PENUTUP
Pasal 37

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja yang telah ditetapkan ini harus melalui Keputusan Direktur RS Prima Husada.

BAB XXVII
Pasal 38

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 10 September 2025
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes